



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

**LAPORAN
KOMITE PMKP RS PRIMA HUSADA
MALANG
BULAN FEBRUARI TAHUN 2026**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan yang Maha Esa, karena berkat rahmatnya penyusunan Laporan Komite PMKP bulan Februari Tahun 2026 Rumah Sakit Prima Husada Malang ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik sehingga dapat dilaporkan kepada Pemilik Rumah Sakit Prima Husada (PT. Disa Prima Medika). Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien dilakukan berdasarkan tersedianya data, penggunaan data secara efektif dapat dilakukan secara *evidence-based* praktek klinik dan *evidence-based management*, berhubung sebagian besar rumah sakit mempunyai sumber daya terbatas, maka rumah sakit tidak dapat mengumpulkan data untuk semua hal yang diinginkan. Jadi rumah sakit memilih proses dan hasil *outcome* praktik klinik dan manajemen yang harus dinilai atau diukur dengan mengacu pada misi rumah sakit, kebutuhan pasien dan jenis pelayanan. Penilaian sering terfokus pada proses yang berimplikasi resiko tinggi, diberikan dalam volume besar atau cenderung menimbulkan masalah. Pimpinan rumah sakit memiliki peranan kunci untuk memastikan rencana mutu dan keselamatan pasien membentuk budaya organisasi rumah sakit dan memberi dampak pada setiap aspek kegiatan berupa Standar Pelayanan Minimal dan pencapaiannya sesuai indikator yang dipergunakan di setiap unit pelayanan di Rumah Sakit Prima Husada.

Dengan tersusunnya Laporan Komite PMKP bulan Februari tahun 2026 Rumah Sakit Prima Husada Malang ini, kami mengucapkan terima kasih kepada tim yang telah membantu terselesaikannya laporan ini sehingga dapat dipergunakan untuk pendekatan sistemik dalam hal aplikasi proses dan pengetahuan yang seragam dalam melaksanakan semua kegiatan mutu dan keselamatan pasien rumah sakit.

Penyusun

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Visi Rumah Sakit Prima Husada adalah menjadi rumah sakit berkualitas prima pilihan seluruh lapisan masyarakat. Untuk dapat mewujudkan visi Rumah Sakit Prima Husada tersebut, maka didukung oleh 3 misi sebagai berikut: 1) Memberikan pelayanan kesehatan dengan aman, tepat, cepat, akurat. 2) Mengutamakan kepuasan dan keselamatan pasien. 3) Meningkatkan mutu pelayanan yang berkelanjutan. Dalam upaya memberikan pelayanan berkualitas prima yang mengedepankan peningkatan mutu dan keselamatan pasien sesuai dengan Standar Akreditasi Rumah Sakit Kementerian Kesehatan (STARKES). Kegiatan ini dilakukan di setiap unit terkait untuk mengukur kinerja pelayanan rumah sakit dan sebagai manajemen kontrol untuk mendukung pengambilan keputusan.

Program peningkatan mutu dan keselamatan pasien Rumah Sakit Prima Husada pada tahun 2025 menetapkan indikator rumah sakit yang sesuai dengan STARKES. Berdasarkan standar PMKP 3, dapat diklasifikasikan indikator rumah sakit sebagai berikut: indikator mutu nasioanal (INM), Indikator mutu sasaran keselamatan pasien, Indikator mutu prioritas klinis rumah sakit, Indikator mutu tujuan strategis, indikator mutu perbaikan sistem, Indikator mutu prioritas unit (IMP-Unit).

B. Tujuan

Tujuan Umum

Mengetahui mutu pelayanan dan penerapan keselamatan pasien di Rumah Sakit Prima Husada.

Tujuan Khusus

- a. Mengevaluasi peningkatan mutu dan keselamatan pasien Rumah Sakit Prima Husada melalui pemantauan indikator mutu yang telah ditetapkan pada rapat kerja akhir tahun.
- b. Mengevaluasi pelaksanaan program mutu spesifik lain yang dilakukan oleh tim/ komite/ unit terkait dengan peningkatan mutu dan keselamatan pasien.
- c. Mendapatkan rekomendasi dari dewan pengawas mengenai program mutu pelayanan dan penerapan keselamatan pasien di Rumah Sakit Prima Husada

BAB II

KEGIATAN PEMANTAUAN INDIKATOR MUTU RUMAH SAKIT TAHUN 2025

A. Kegiatan Pokok

Kegiatan pemantauan indikator mutu pada bulan Februari tahun 2026 yang dilaporkan pada Bulan Maret Tahun 2026.

B. Kegiatan yang Dilakukan

1. Melakukan pemantauan indikator mutu secara berkesinambungan
2. Melakukan tabulasi terhadap data hasil pemantauan indikator mutu
3. Melakukan penyampaian hasil pemantauan indikator mutu oleh masing-masing bagian/ unit
4. Menyusun laporan hasil pemantauan indikator mutu

C. Jadwal Kegiatan

1. Melakukan pelaporan hasil pemantauan indikator mutu oleh masing-masing bagian/ unit dilakukan setiap bulan, menyusun program perbaikan mutu oleh tim peningkatan mutu rumah sakit dilaporkan pada saat rapat bulanan.
2. Melakukan tabulasi terhadap data hasil pemantauan indikator mutu
3. Menyusun laporan hasil pemantauan indikator mutu dan keselamatan pasien rumah sakit setiap tiga bulan.
4. Melakukan penyampaian hasil pemantauan indikator mutu

D. Pencatatan dan Pelaporan

Pencatatan dilakukan oleh petugas pengumpul data unit, kemudian dilakukan rekapitulasi dan analisa oleh penanggungjawab pengumpul data. Hasil analisis tersebut kemudian dilaporkan ke kepala instalasi/ unit, hasil ditulis pada Form Supervisi dilengkapi laporan tindak lanjut program untuk indikator yang belum sesuai dengan standar yang ditetapkan atau setiap ditemukan suatu permasalahan disetiap instalasi kerja dan ditembuskan Sub Komite Peningkatan Mutu.

BAB III
HASIL KEGIATAN DAN PEMBAHASAN

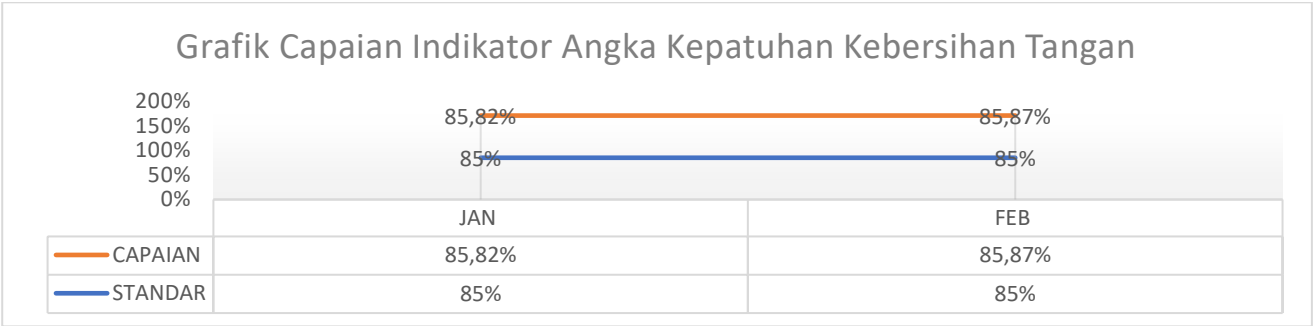
3.1 Indikator Mutu Nasional

NO	JUDUL	STAND	Jan '26	Feb '26	Mar '26	Apr '26	Mei '26	Jun '26	Juli '26	Agust '26	Sept '26	Okt '26	Nov '26	Des '26	Rata-Rata
1.	Angka Kepatuhan Kebersihan Tangan	≥ 85%	85.82%	85.87%											
2.	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)	100%	96.82%	96.88%											
3.	Kepatuhan Identifikasi Pasien	100%	99.96%	99.06%											
4.	Waktu Tanggap Operasi Seksio Sesarea Emergensi	≥ 80%	100%	100%											
5.	Waktu Tunggu Rawat Jalan	≥ 80%	89.9%	86.3%											
6.	Penundaan Operasi Elektif	≤ 5%	0%	0%											
7.	Kepatuhan Waktu Visite Dokter	≥ 80%	66.67%	73.63%											
8.	Pelaporan Hasil Kritis Laboratorium	100%	100%	100%											
9.	Kepatuhan Penggunaan Formularium Nasional	≥ 80%	86.13%	86.07%											
10.	Kepatuhan Terhadap Alur Klinis (Clinical Pathway)	≥ 80%	30.51%	16.11%											
11.	Kepatuhan Upaya Pencegahan Risiko Pasien Jatuh	100%	91.54%	93.31%											

12.	Kecepatan Waktu Tanggap Komplain	≥ 80%	100%	100%											
13.	Kepuasan Pasien	≥ 76,61	99.7%	99.89%											

3.1.1 Angka Kepatuhan Kebersihan Tangan

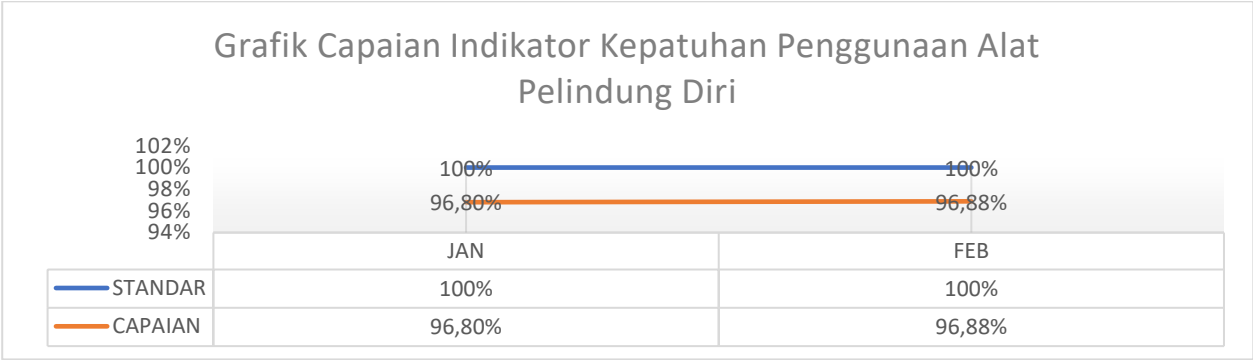
Gambar 1. Grafik Capaian Indikator Angka Kepatuhan Kebersihan Tangan



PLAN	Berdasarkan hasil monitoring indikator mutu kepatuhan kebersihan tangan oleh petugas di unit pelayanan, ditemukan bahwa capaian kepatuhan kebersihan tangan belum mencapai standar yang ditetapkan rumah sakit (misal standar ≥85%). Permasalahan yang ditemukan antara lain petugas belum konsisten melakukan 5 momen hand hygiene, kurangnya pengawasan, serta ketersediaan handrub yang kadang tidak terisi penuh. Rencana perbaikan yang dilakukan adalah meningkatkan sosialisasi 5 momen kebersihan tangan, melakukan monitoring dan supervisi rutin, memastikan ketersediaan sarana hand hygiene, serta melakukan edukasi ulang kepada petugas kesehatan.				
DO	Tim PPI bersama unit terkait melakukan sosialisasi kembali mengenai 5 momen kebersihan tangan kepada seluruh petugas kesehatan, melakukan inspeksi ketersediaan handrub dan wastafel, memasang poster edukasi di area pelayanan, serta melakukan audit kepatuhan kebersihan tangan secara berkala. Kepala unit juga diminta melakukan pengawasan langsung kepada petugas.				
STUDY	Setelah dilakukan intervensi, dilakukan evaluasi melalui audit kepatuhan kebersihan tangan pada periode berikutnya. Hasil monitoring menunjukkan adanya peningkatan kepatuhan petugas dalam melakukan kebersihan tangan, walaupun masih ditemukan beberapa petugas yang belum konsisten pada momen sebelum kontak dengan pasien.				
ACTION/RTL	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Meningkatkan kebersihan tangan.	Meningkatkan kepatuhan kebersihan tangan.	Seluruh petugas pelayanan pasien	Upaya perbaikan akan terus dilanjutkan dengan melakukan monitoring rutin, pemberian umpan balik kepada unit dengan capaian rendah, penguatan budaya keselamatan pasien, serta memastikan ketersediaan sarana kebersihan tangan di setiap unit pelayanan. Apabila capaian	- Perawat /Bidan - Dokter - Karu - IPCLN/IPCN	Satu bulan

			sudah memenuhi standar, kegiatan ini akan dipertahankan sebagai bagian dari budaya keselamatan pasien di rumah sakit.		
--	--	--	---	--	--

3.1.2 Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)
 Gambar 2. Grafik Capaian Indikator Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri

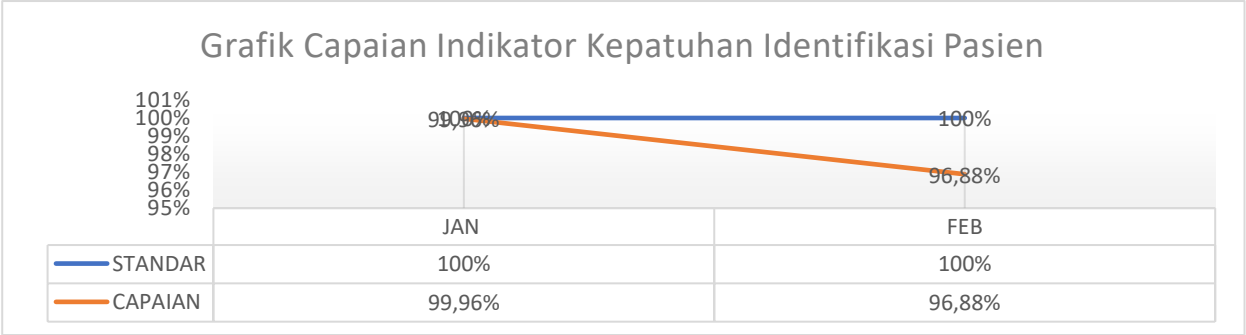


PLAN	Berdasarkan hasil monitoring indikator mutu kepatuhan penggunaan APD oleh petugas di unit pelayanan, ditemukan bahwa capaian kepatuhan penggunaan APD belum sepenuhnya memenuhi standar yang ditetapkan rumah sakit. Permasalahan yang ditemukan antara lain petugas belum konsisten menggunakan APD sesuai jenis tindakan, kurangnya pemahaman terkait risiko paparan, serta pengawasan yang belum optimal. Oleh karena itu direncanakan upaya perbaikan berupa sosialisasi kembali terkait penggunaan APD sesuai standar, peningkatan pengawasan oleh kepala unit, serta memastikan ketersediaan APD di setiap unit pelayanan.
DO	Tim PPI bersama Komite PMKP dan kepala unit melakukan sosialisasi ulang mengenai pentingnya penggunaan APD sesuai standar keselamatan kerja dan pencegahan infeksi. Dilakukan pemasangan poster edukasi penggunaan APD di area pelayanan, pengecekan ketersediaan APD di setiap unit, serta pelaksanaan monitoring dan audit kepatuhan penggunaan APD secara berkala oleh petugas yang ditunjuk.
STUDY	Setelah dilakukan intervensi, dilakukan evaluasi melalui audit kepatuhan penggunaan APD pada periode monitoring berikutnya. Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan kepatuhan petugas dalam menggunakan APD, namun masih ditemukan

	beberapa petugas yang belum menggunakan APD secara lengkap terutama pada situasi tertentu seperti tindakan cepat atau kondisi pelayanan yang ramai				
ACTION/RTL	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Meningkatkan kepatuhan pemakaian APD.	Meningkatkan kepatuhan pemakaian APD di unit.	Tercapainya kepatuhan APD hingga maksimal 100%.	Rumah sakit akan terus melakukan monitoring dan evaluasi kepatuhan penggunaan APD secara berkala. Kepala unit diminta memberikan pengawasan langsung kepada petugas serta memberikan umpan balik kepada petugas yang belum patuh. Selain itu, rumah sakit akan memastikan ketersediaan APD secara berkelanjutan serta mempertahankan edukasi dan sosialisasi sebagai bagian dari budaya keselamatan pasien dan keselamatan petugas.	- Kepala ruangan dan IPCN - Kepala ruangan - Kepala Bidang	Satu Bulan

3.1.3 Kepatuhan Identifikasi Pasien

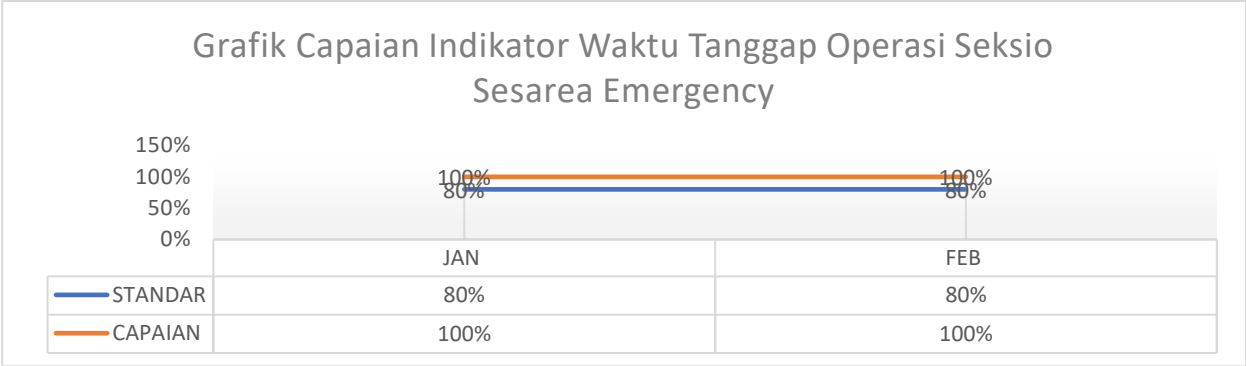
Gambar 3. Grafik Capaian Indikator Kepatuhan Identifikasi Pasien



PLAN	Berdasarkan hasil monitoring indikator mutu kepatuhan identifikasi pasien di unit pelayanan, ditemukan bahwa kepatuhan petugas dalam melakukan identifikasi pasien belum sepenuhnya sesuai dengan standar yang ditetapkan rumah. Beberapa temuan antara lain petugas tidak melakukan identifikasi menggunakan minimal dua identitas pasien (nama lengkap dan tanggal lahir / nomor rekam medis) sebelum tindakan, pemberian obat, maupun pengambilan spesimen. Selain itu masih terdapat petugas yang tidak melakukan konfirmasi ulang kepada pasien. Oleh karena itu direncanakan upaya perbaikan berupa sosialisasi ulang SPO identifikasi pasien, peningkatan pengawasan oleh kepala unit, serta penguatan budaya keselamatan pasien.				
DO	Tim PMKP bersama kepala unit melakukan sosialisasi kembali terkait standar identifikasi pasien kepada seluruh petugas pelayanan. Dilakukan pengingat melalui poster atau media edukasi mengenai pentingnya identifikasi pasien sebelum tindakan, pemberian obat, pengambilan sampel laboratorium, maupun tindakan lainnya. Selain itu dilakukan monitoring dan audit kepatuhan identifikasi pasien secara berkala serta pengawasan langsung oleh kepala unit.				
STUDY	Setelah dilakukan intervensi, dilakukan evaluasi melalui audit kepatuhan identifikasi pasien pada periode monitoring berikutnya. Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan kepatuhan petugas dalam melakukan identifikasi pasien, namun masih ditemukan beberapa petugas yang belum konsisten melakukan identifikasi terutama pada kondisi pelayanan yang sibuk atau pada pasien yang sudah dikenal oleh petugas.				
ACTION/RTL	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Mempertahankan kepatuhan identifikasi pasien	Mempertahankan kepatuhan identifikasi pasien	Tercapainya indikator kepatuhan identifikasi pasien pada bulan berikutnya.	Rumah sakit akan terus melakukan monitoring dan evaluasi kepatuhan identifikasi pasien secara berkala. Kepala unit diminta memberikan pengawasan secara langsung serta memberikan umpan balik kepada petugas yang belum patuh. Edukasi terkait keselamatan pasien akan terus dilakukan secara berkelanjutan agar kepatuhan identifikasi pasien dapat mencapai dan mempertahankan standar yang telah ditetapkan oleh rumah sakit.	Seluruh petugas yang melakukan pelayanan di RS.	Satu Bulan

3.1.4 Waktu Tanggap Operasi Seksio Sesarea Emergency

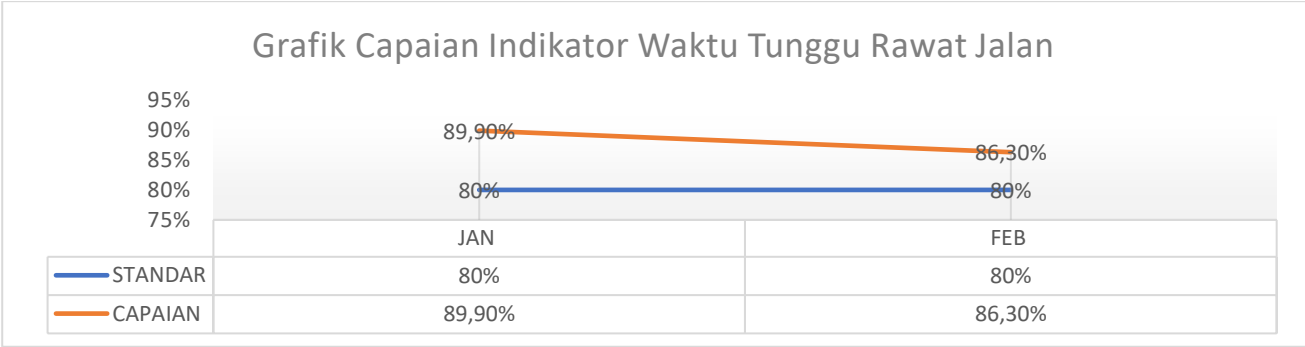
Gambar 4. Grafik Capaian Indikator Waktu Tanggap Operasi Seksio Sesarea Emergency



Dari grafik indikator waktu tanggap SC emergency bulan Januari hingga Februari tahun 2026 diketahui capaian telah mencapai standart 100%, hal ini berkat kerjasama yang baik antara unit Instalasi Gawat Darurat, Unit Maternitas dan Instalasi Kamar Operasi serta manajemen Rumah Sakit Prima Husada Malang yang telah bersinergi untuk mempertahankan capaian waktu SC emergency. Ketersediaan SDM serta sarana dan prasarana yang mendukung juga menjadi faktor tercapainya indikator waktu tanggap operasi SC emergency. Capaian ini diharapkan dapat dipertahankan di tahun berikutnya.

3.1.5 Waktu Tunggu Rawat Jalan

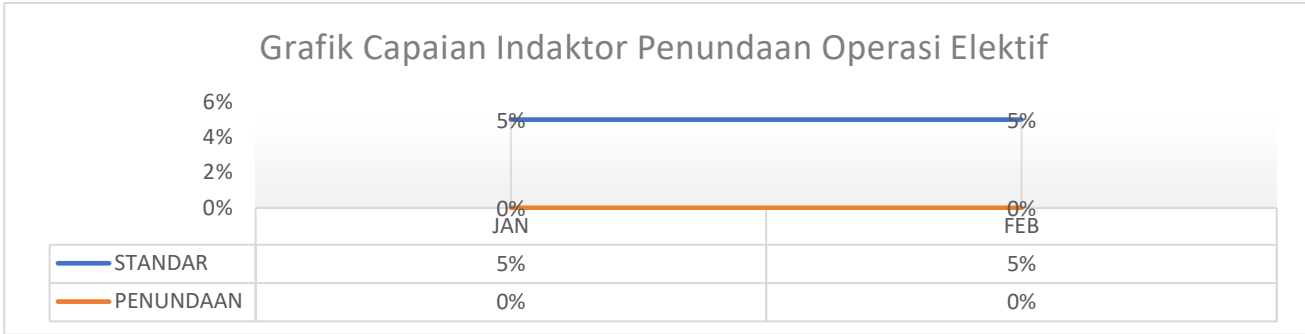
Gambar 5. Grafik Capaian Indikator Waktu Tunggu Rawat Jalan



PLAN	Berdasarkan grafik capaian indikator mutu waktu tunggu rawat jalan di atas dapat diketahui bahwa capaian bulan Januari telah mencapai standart yaitu 89.90% dan bulan Februari yaitu 86.3%. Capaian belum maksimal 100% karena pendaftaran menumpuk pada jam jam tertentu dan masih ada keterlambatan kedatangan dokter. Rencana perbaikan yang akan dilakukan adalah opyimalisasi sistem antrean dan pendaftaran online dan penyesuaian jam praktik dokter.				
DO	- Melakukan sosialisasi alur pelayanan rawat jalan - Mengoptimalkan pendaftaran online dan sistem antrean - Monitoring ketepatan waktu kedatangan dokter - Pengaturan jam pelayanan berdasarkan pola kunjungan pasien				
STUDY	Setelah dilakukan intervensi, dilakukan evaluasi melalui monitoring waktu tunggu pelayanan rawat jalan pada periode berikutnya. Hasil evaluasi menunjukkan adanya penurunan waktu tunggu pasien dan peningkatan kepuasan pasien terhadap pelayanan rawat jalan, meskipun pada jam-jam tertentu masih terjadi peningkatan jumlah pasien yang menyebabkan waktu tunggu menjadi lebih lama.				
ACTION/RTL	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Meningkatkan capaian indikator waktu tunggu rawat jalan	Meningkatkan capaian indikator waktu tunggu rawat jalan	Tercapainya indikator waktu tunggu rawat jalan hingga 100%	Rumah sakit akan terus melakukan monitoring waktu tunggu pelayanan rawat jalan secara berkala. Koordinasi dengan dokter dan unit terkait akan terus dilakukan untuk memastikan pelayanan berjalan sesuai jadwal. Selain itu rumah sakit akan melakukan evaluasi terhadap sistem pendaftaran dan pengaturan jadwal pelayanan guna mempertahankan dan meningkatkan capaian indikator mutu waktu tunggu rawat jalan.	Manajemen	- Satu Bulan

3.1.6 Penundaan Operasi Elektif

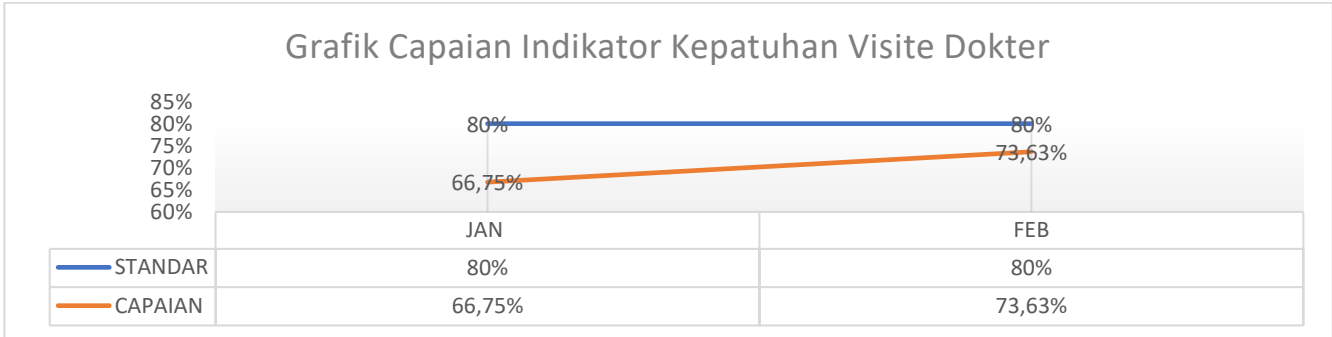
Gambar 6. Grafik capaian Indikator Penundaan Operasi Elektif



Dari grafik indikator penundaan operasi elektif bulan Januari hingga Febrauri tahun 2026 diketahui capaian telah mencapai standart, hal ini berkat kerjasama yang baik antara unit Instalasi Rawat Jalan, Instalasi Rawat Inap dan Instalasi Kamar Operasi serta manajemen Rumah Sakit Prima Husada Malang yang telah bersinergi untuk mempertahankan capaian indikator penundaan operasi elektif , perencanaan yang matang dari segi SDM, alat dan ruang operasi juga telah dilakukan guna meminimalisir terjadinya penundaan operasi elektif.

3.1.7 Kepatuhan Waktu Visite Dokter

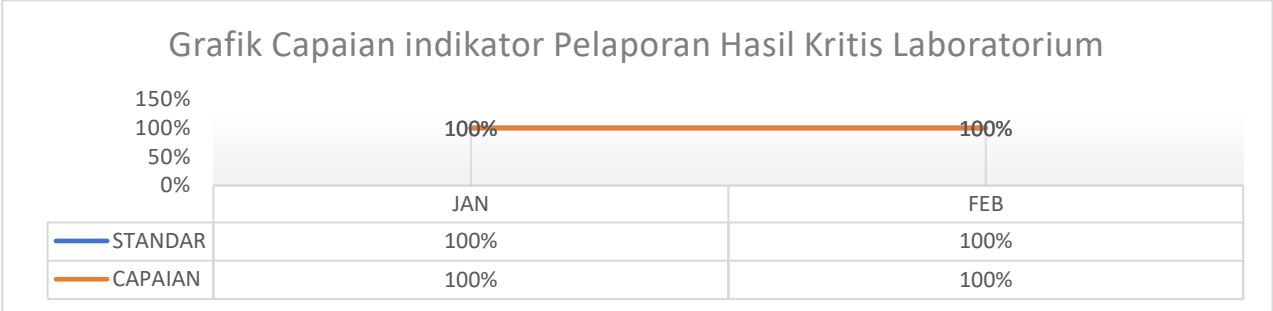
Gambar 7. Grafik Capaian Indikator Kepatuhan Visite Dokter



PLAN	Berdasarkan grafik capaian indikator kepatuhan visite dokter dapat diketahui bahwa capaian di bulan Januari tahun 2026 yaitu 66.75% dan bulan Februari yaitu 73.63%. Hal tersebut memang tidak mencapai standart jika di nilai waktu visite jam 07.00 hingga jam 14.00 karena dokter memiliki jadwal praktik ditempat lain tetapi DPJP telah melakukan visite 1x setiap harinya di jam yang sudah disepakati atau menyesuaikan jadwal praktik di rumah sakit Prima Husada Malang. Rencan perbaikan yang akan dilakukan adalah penguatan komunikasi dengan DPJP dalam rangka komitmen visite sesuai jam yang disepakati.				
DO	- Penguatan komunikasi dengan DPJP dalam rangka komitmen visite sesuai jam yang disepakati - Koordinasi perawat dengan DPJP terkait jadwal visite - Monitoring pelaksanaan visite oleh manajemen/unit terkait				
STUDY	Berdasarkan grafik capaian indikator kepatuhan visite dokter dapat diketahui bahwa capaian di bulan Januari tahun 2026 yaitu 66.75% dan bulan Februari yaitu 73.63%. Hal tersebut memang tidak mencapai standart jika di nilai waktu visite jam 07.00 hingga jam 14.00 karena dokter memiliki jadwal praktik ditempat lain tetapi DPJP telah melakukan visite 1x setiap harinya di jam yang sudah disepakati atau menyesuaikan jadwal praktik di rumah sakit Prima Husada Malang. Rencan perbaikan yang akan dilakukan adalah penguatan komunikasi dengan DPJP dalam rangka komitmen visite sesuai jam yang disepakati.				
	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Meningkatkan kepatuhan waktu visite dokter	Meningkatkan kepatuhan waktu visite dokter	Capaian Kepatuhan Visite dokter bisa meningkat pada bulan selanjutnya	Rumah sakit akan terus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan waktu visite dokter secara berkala. Koordinasi dengan Komite Medik akan terus dilakukan untuk meningkatkan kedisiplinan waktu visite. Selain itu, kepala ruang rawat inap diminta untuk melakukan pengingat dan pelaporan apabila terdapat dokter yang belum melakukan visite sesuai waktu yang telah ditentukan. Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan mutu pelayanan serta kepuasan pasien selama menjalani perawatan di rumah sakit.	Manajemen RS	Satu Bulan

3.1.8 Pelaporan Hasil Kritis Laboratorium

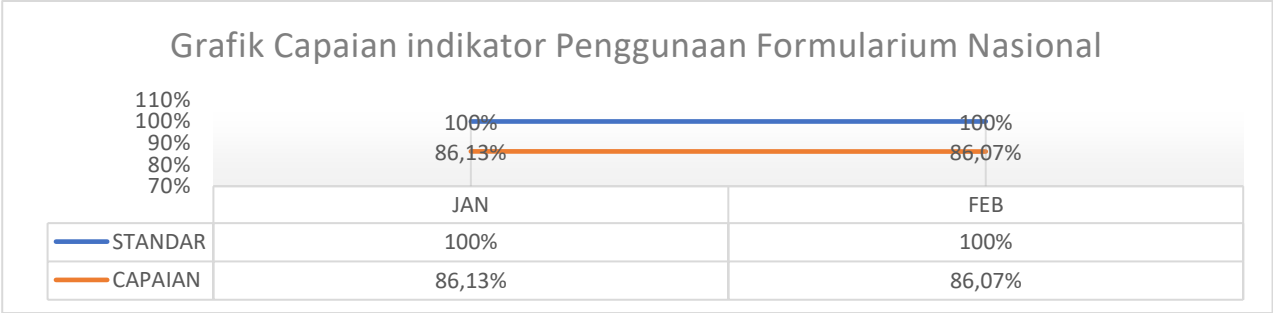
Gambar 8. Grafik Capaian Indikator Pelaporan Hasil Kritis Laboratorium



Berdasarkan data capaian indikator mutu pelaporan hasil kritis laboratorium di atas, dapat diketahui bahwa capaian di bulan Januari dan Februari tahun 2026 telah mencapai standart 100%. Kegiatan yang akan terus kami lakukan yaitu sosialisai kebijakan dan SPO pelaporan hasil kritis, penguatan alur komunikasi hasil kritis dan menjadikan pelaporan hasil kritis sebagai budaya keselamatan pasien.

3.1.9 Kepatuhan Penggunaan Formularium Nasional

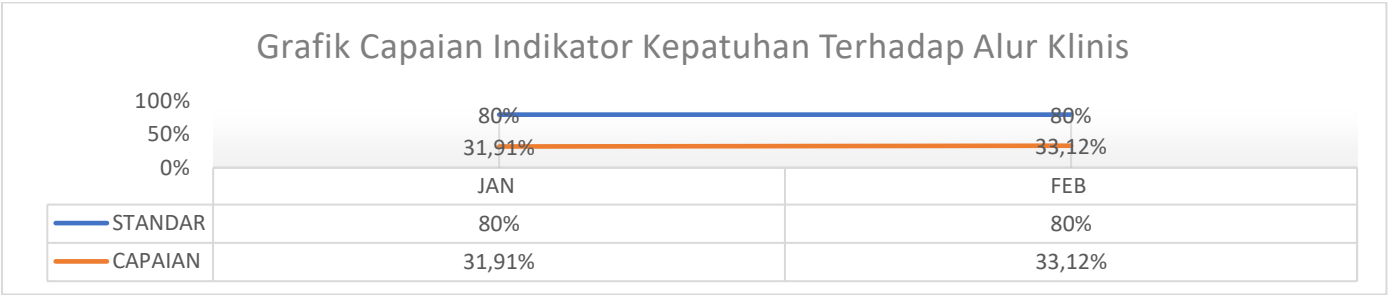
Gambar 9. Grafik Capaian Kepatuhan Penggunaan Formularium Nasional



PLAN	Berdasarkan hasil monitoring indikator mutu kepatuhan penggunaan Formularium Nasional (Fornas), masih ditemukan penggunaan obat yang tidak sesuai dengan daftar Formularium Nasional sehingga capaian indikator belum memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh rumah sakit. Beberapa faktor yang mempengaruhi antara lain masih kurangnya pemahaman dokter terhadap daftar obat dalam Formularium Nasional, belum optimalnya sosialisasi terkait pembaruan Fornas, serta belum adanya pengingat pada sistem peresepan apabila obat yang diresepkan tidak termasuk dalam Fornas. Oleh karena itu direncanakan upaya perbaikan melalui sosialisasi penggunaan Formularium Nasional kepada tenaga medis, penyediaan daftar Fornas terbaru di setiap unit pelayanan, peningkatan peran instalasi farmasi dalam melakukan skrining resep, serta pelaksanaan audit resep secara berkala untuk memantau kepatuhan penggunaan Fornas.				
DO	Upaya perbaikan dilakukan dengan melaksanakan sosialisasi kepada dokter dan tenaga kesehatan mengenai pentingnya penggunaan obat sesuai Formularium Nasional. Selain itu instalasi farmasi mendistribusikan atau menyediakan daftar Formularium Nasional terbaru yang dapat diakses oleh tenaga medis di unit pelayanan. Petugas farmasi juga melakukan skrining terhadap resep yang masuk untuk memastikan kesesuaian obat dengan Formularium Nasional serta melakukan konfirmasi kepada dokter apabila ditemukan resep yang tidak sesuai. Tim PMKP bersama instalasi farmasi melakukan pengumpulan dan monitoring data penggunaan obat sesuai Fornas secara berkala.				
STUDY	Selanjutnya dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut dengan mengumpulkan data penggunaan obat dari instalasi farmasi dan menghitung persentase kepatuhan penggunaan Formularium Nasional. Hasil capaian indikator kemudian dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan oleh rumah sakit. Dari hasil evaluasi tersebut dapat diketahui apakah terjadi peningkatan kepatuhan penggunaan Formularium Nasional serta mengidentifikasi kendala yang masih terjadi selama pelaksanaan program.				
	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Meningkatkan kepatuhan penggunaan formularium nasional	Meningkatkan kepatuhan penggunaan formularium nasional	Capaian Kepatuhan penggunaan formularium nasional bisa meningkat pada bulan selanjutnya	erdasarkan hasil evaluasi, apabila capaian indikator masih belum memenuhi standar maka akan dilakukan tindak lanjut berupa sosialisasi ulang kepada tenaga medis, pembinaan kepada unit dengan tingkat kepatuhan rendah, serta penguatan proses skrining resep oleh instalasi farmasi. Selain itu rumah sakit juga dapat mengoptimalkan sistem informasi rumah sakit dengan menambahkan fitur pengingat atau notifikasi apabila obat yang diresepkan tidak termasuk dalam Formularium Nasional. Monitoring dan evaluasi terhadap indikator ini akan terus dilakukan secara berkala dan hasilnya dilaporkan	Manajemen RS	Satu Bulan

			kepada Komite PMKP serta manajemen rumah sakit sebagai dasar perbaikan mutu pelayanan.		
--	--	--	--	--	--

3.1.10 Kepatuhan Terhadap Alur Klinis (Clinical Pathway)
 Gambar 10. Grafik Capaian Indikator Kepatuhan Terhadap Alur Klinis

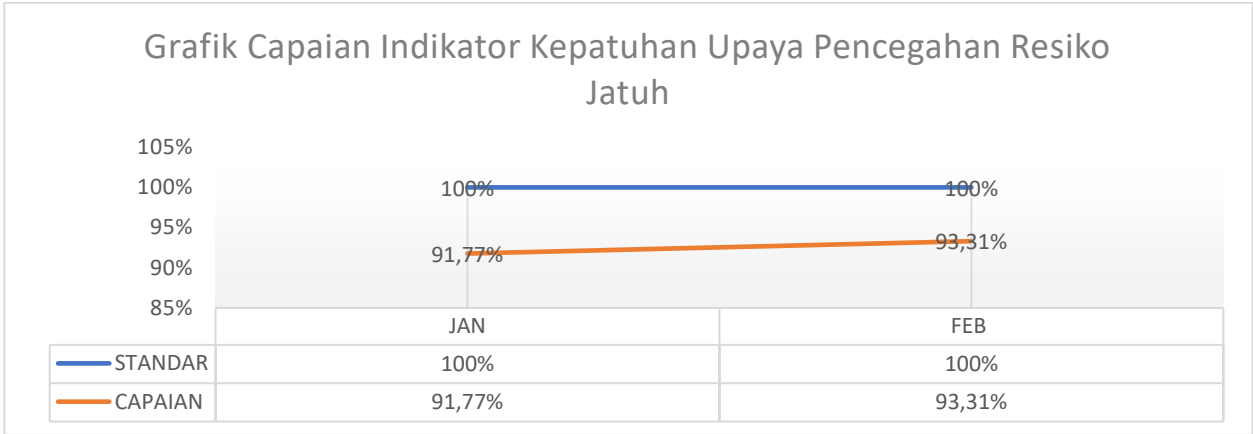


PLAN	Berdasarkan hasil monitoring indikator mutu kepatuhan terhadap alur klinis, capaian pada bulan Januari sebesar 31,91% dan bulan Februari sebesar 33,12%, masih jauh di bawah standar rumah sakit yaitu 80%. Hal ini menunjukkan bahwa tenaga medis belum sepenuhnya patuh dalam menggunakan atau mengisi dokumen alur klinis (clinical pathway) pada pasien dengan diagnosis yang telah ditetapkan. Beberapa faktor penyebab yang teridentifikasi antara lain kurangnya pemahaman petugas mengenai penggunaan alur klinis, keterbatasan waktu dalam pengisian dokumen, serta kurangnya monitoring dari unit terkait. Oleh karena itu direncanakan upaya perbaikan berupa sosialisasi kembali mengenai penggunaan alur klinis, peningkatan monitoring kepatuhan pengisian oleh kepala unit, serta koordinasi dengan Komite Medik dan DPJP.
------	---

DO	Tim PMKP bersama Komite Medik melakukan sosialisasi dan edukasi kepada dokter dan tenaga kesehatan terkait pentingnya penggunaan alur klinis dalam pelayanan pasien. Selain itu dilakukan pengingat kepada DPJP dan petugas terkait untuk mengisi alur klinis sesuai diagnosis yang telah ditentukan. Kepala unit rawat inap juga diminta melakukan monitoring kelengkapan pengisian alur klinis pada rekam medis pasien.				
STUDY	Setelah dilakukan intervensi, dilakukan evaluasi terhadap kepatuhan penggunaan alur klinis pada periode monitoring berikutnya. Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan capaian dari 31,91% pada bulan Januari menjadi 33,12% pada bulan Februari, namun capaian tersebut masih belum mencapai standar yang ditetapkan rumah sakit. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi alur klinis masih perlu ditingkatkan.				
	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Meningkatkan kepatuhan terhadap alur klinis	Meningkatkan kepatuhan terhadap alur klinis	Indikator kepatuhan terhadap alur klinis bisa mencapai standrt	Rumah sakit akan terus melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap kepatuhan penggunaan alur klinis. Komite Medik bersama Komite PMKP akan melakukan penguatan implementasi clinical pathway kepada DPJP serta melakukan supervisi terhadap pengisian dokumen alur klinis dalam rekam medis pasien. Selain itu, akan dilakukan evaluasi berkala serta pemberian umpan balik kepada unit pelayanan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap alur klinis sehingga capaian indikator dapat mencapai standar yang ditetapkan.	Manajemen RS	Satu Bulan

3.1.11 Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Jatuh

Gambar 11. Grafik Capaian Indikator Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Jatuh

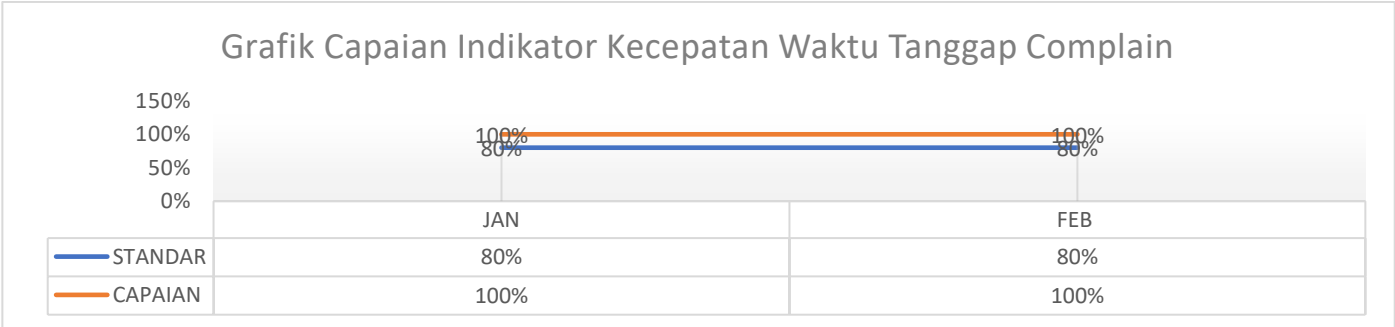


PLAN	Berdasarkan grafik capaian indikator kepatuhan upaya pencegahan risiko jatuh pada bulan Januari yaitu 91.77% dan bulan Februari 93.31%. Capaian belum mencapai standart 100% karena kepatuhan petugas dalam melaksanakan upaya pencegahan risiko jatuh belum optimal, edukasi pasien dan keluarga belum optimal, monitoring dan dokukemntasi belum lengkap. Rencana perbaikan yang akan dilakukan adalah sosialisasi ulang SOP pencegahan risiko jatuh dan audit kepatuhan pencegahan risiko jatuh secara rutin.				
DO	- Melaksanakan pengkajian risiko jatuh pada pasien saat masuk dan berkala - Pemberian tanda risiko jatuh (gelang/label/stiker) - Penerapan intervensi pencegahan sesuai tingkat risiko - Edukasi pasien dan keluarga tentang pencegahan jatuh				
STUDY	Capaian indikator kepatuhan upaya pencegahan risiko jatuh pada bulan Januari yaitu 91.77% dan bulan Februari 93.31%. Capaian belum mencapai standart 100% karena kepatuhan petugas dalam melaksanakan upaya pencegahan risiko jatuh belum optimal, edukasi pasien dan keluarga belum optimal, monitoring dan dokukemntasi belum lengkap. Rencana perbaikan yang akan dilakukan adalah sosialisasi ulang SOP pencegahan risiko jatuh dan audit kepatuhan pencegahan risiko jatuh secara rutin.				
ACTION/RTL	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU

Meningkatkan capaian indikator kepatuhan upaya pencegahan resiko jatuh	Meningkatkan capaian indikator kepatuhan upaya pencegahan resiko jatuh	Capaian indikator kepatuhan terhadap upaya pencegahan resiko jatuh bisa mencapai 100%.	Rumah sakit akan terus melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap kepatuhan upaya pencegahan risiko jatuh. Kepala ruangan diminta untuk melakukan supervisi secara rutin kepada petugas serta memberikan umpan balik apabila ditemukan ketidaksesuaian. Selain itu, edukasi terkait keselamatan pasien akan terus dilakukan agar kepatuhan petugas dalam pencegahan risiko jatuh dapat mencapai dan mempertahankan standar yang telah ditetapkan oleh rumah sakit.	Perawat instalasi rawat inap	- Satu Bulan
--	--	--	---	------------------------------	--------------

3.1.12 Kecepatan waktu tanggap complain

Gambar 12. Grafik Capaian Indikator Kecepatan Waktu Tanggap Complain



Dari grafik indikator waktu tanggap kompalian bulan Januari dan Februari tahun 2026 diketahui capaian telah mencapai standart 100%, hal ini berkat kerjasama yang baik antara PIPP dan juga manajemen Rumah Sakit Prima Husada Malang yang telah bersinergi untuk segera menanggapi dan melakukan tindak lanjut terkait complain yang diterima. Upaya lain yang telah dilakukan adalah mekanisme pelaporan yang mudah bisa langsung melalui PIPP, bisa melalui tlp, WA dan formulir online. Capaian

ini diharapkan dapat dipertahankan di bulan berikutnya. Adanya staf yang terlatih khusus dalam manajemen komplain dan memiliki kemampuan komunikasi yang baik juga menjadi salah satu upaya yang dilakukan supaya indikator kecepatan waktu tanggap complain dapat tercapai.

3.1.13 Kepuasan Pasien

Gambar 3.1.13 Grafik Capaian Indikator Kepuasan Pasien

PLAN	Berdasarkan grafik capaian indikator kepuasan pasien dapat diketahui capaian di bulan Januari yaitu 99.7% dan Februari 99.89%. Capaian telah mencapai standart walaupun belum maksimal 100%. Masih di dapatkan komplain terkait komunikasi petugas yang tidak efektif serta kenyamanan yang kurang optimal. Rencana perbaikan yang akan dilakukan adalah evaluasi hasil survey dan kepuasan, peningkatan komunikasi efektif dan pelayanan prima.				
DO	- Memberikan edukasi pelayanan prima kepada petugas - Menindaklanjuti keluhan dan saran pasien - Perbaikan layanan berdasarkan masukan pasien				
STUDY	Capaian indikator kepuasan pasien dapat diketahui capaian di bulan Januari yaitu 99.7% dan Februari 99.89%. Capaian telah mencapai standart walaupun belum maksimal 100%. Masih di dapatkan komplain terkait komunikasi petugas yang tidak efektif serta kenyamanan yang kurang optimal. Rencana perbaikan yang akan dilakukan adalah evaluasi hasil survey dan kepuasan, peningkatan komunikasi efektif dan pelayanan prima.				
ACTION/RTL	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Meningkatkan capaian Indikator Kepuasan Pasien	Meningkatkan capaian Indikator Kepuasan Pasien	Peningkatan capaian indikator kepuasan pasien	- Memberikan edukasi pelayanan prima kepada petugas - Menindaklanjuti keluhan dan saran pasien - Perbaikan layanan berdasarkan masukan pasien	Seluruh layanan	- Satu Bulan

3.2 Indikator Sasaran Keselamatan Pasien

No.	Judul	Stand	Jan '26	Feb '26	Mar '26	Apr '26	Mei '26	Jun '26	Jul '26	Agust '26	Sept '26	Okt '26	Nov '26	Des '26	Rata-Rata
1.	Kepatuhan verifikasi identitas pasien sebelum pemberian obat pasien rawat jalan (farmasi)	100%	100%	100%											
2.	Kepatuhan pelaporan hasil kritis radiologi (radiologi)	100%	100%	100%											
3.	Kepatuhan penempelan label obat LASA dan obat-obatan High Alert dirawat inap	100%	-	92.14%											
4.	Kepatuhan penandaan lokasi operasi (IKO)	100%	100%	100%											
5.	Kepatuhan Petugas Kesehatan Melakukan 6 langkah cuci tangan (PPI)	100%	85.05%	85.70%											
6.	Kepatuhan pemasangan handrell dan penguncian roda brankar (IGD, IRNA, IKO)	100%	-	87.11%											

3.3 Indikator Mutu Pelayanan Klinis Prioritas

No.	Judul	Stand	Jan '26	Feb '26	Mar '26	Apr '26	Mei '26	Jun '26	Jul '26	Agust '26	Sept '26	Okt '26	Nov '26	Des '26	Rata-Rata
1.	Kepatuhan Pengisian Form Discharge Planing pasien DM dengan ulkus (Rawat Inap)	100%		7.08%											
2.	Kepatuhan Pengisian Form Edukasi pada pasien DM dengan ulkus (Rawat Inap)	100%		12.1%											
3.	Kepatuhan PPK dan CP Pasien DM (Rawat Inap)	100%		8.341%											

3.4 Tujuan Strategis

NO	JUDUL	STAND	Jan '26	Feb '26	Mar '26	Apr '26	Mei '26	Jun '26	Juli '26	Agust '26	Sept '26	Okt '26	Nov '26	Des '26	Rata-Rata
1.	Kejadian komplain pasien / keluarga di <i>google review</i>	0	5	1											

3.5 Perbaikan Sistem

No	Judul	Stand	Jan '26	Feb '26	Mar '26	Apr '26	Mei '26	Jun '26	Jul '26	Agust '26	Sept '26	Okt '26	Nov '26	Des '26	Rata-Rata
1.	Kepatuhan petugas dalam pemeliharaan alat	100%	100%	100%											
2.	Waktu tunggu obat racikan kurang dari 60 menit	100%	10.38%	17.34%											

BAB IV
HASIL KEGIATAN MUTU PRIORITAS UNIT

NO	JUDUL INDIKATOR MUTU	UNIT	Bulan												STAND ART
			Jan '26	Feb '26	Mar '26	Apr '26	Mei '26	Jun '26	Jul '26	Agt '26	Sep '26	Okt '26	Nov '26	Des '26	
1	Ketidaklengkapan E-RM pengkajian awal IGD dan SPRI	IGD	-	54.72%											0%
2	Kejadian ketidakpatuhan staf medis dalam penempatan pasien dengan EWS	IGD	-	0											0
3	Kejadian kesalahan asuhan medis dokter IGD	IGD	-	0											0
4	Kejadian kesalahan asuhan medis DPJP	Rawat Inap	-	0											0
5	Angka Kejadian pasien tidak dilaksanakan visite	Rawat Inap	-	55.64%											0%
6	Ketidaklengkapan e-rm asuhan pasien selama di rawat inap	Rawat Inap	-	60.71%											0%
7	Ketidaklengkapan e-rm asuhan pasien selama di ICU dan HCU	ICU / HCU	-	70.45%											0%
8	Kejadian Kesalahan saat hand over (serah terima)	ICU / HCU	0	0											0

9	Kejadian Keterlambatan pemasangan intubasi pasien	ICU / HCU	0	0											0
10	Angka pasien kembali ke perawatan intensive dengan kasus yang sama <72 jam	ICU/HCU	0	4											<3%
11	Kepatuhan DPJP terhadap Jadwal Praktek	Rawat Jalan	-	87.6%											100%
12	Ketidakiengkapan e-rm asuhan pasien selama di rrawat jalan	Rawat Jalan	-	2.55%											0%
13	Target Pasien PRB dan iterasi	Rawat Jalan	-	-											100%
14	Kegagalan pelaksanaan layanan di rawat jalan (pasien gagal pelayanan atas kesalahan) setiap hari	Rawat Jalan	-	0											0
15	Kegagalan pelaksanaan layanan di rawat jalan (pasien gagal pelayanan atas kesalahan) setiap hari	Fisioterapi	5	2											0
16	Pelayanan tidak sesuai program terapi	Fisoterapi	0%	0%											0%
17	Ketidakiengkapan e-rm asuhan pasien selama di maternitas	Maternitas	11%	13%											0%
18	Angka kematian ibu	Maternitas	0%	0%											0%
19	Kejadian perdarahan post partum	Maternitas	3	3											0

20	Angka Kejadian partus macet	Maternitas	18.5%	31.3%											<10%
21	Kejadian eklamsi	Maternitas	3	0											0
22	Kejadian pre eklamsi	Maternitas	0	1											0
23	Kejadian infeksi nifas	Maternitas	0	0											0
24	Angka Kematian Bayi	Neonatalogi	0%	0%											0%
25	Kejadian Keterlambatan pemasangan Intubasi pada pasien dengan indikasi	Neonatalogi	0	0											0
26	Kejadian SHK yang di tolak Dinkes	Neonatalogi	0	0											0
27	Kejadian re operasi	IKO	0	0											0
28	Ketidaklengkapan pengisian e-rm laporan operasi dan anestesi sedasi pasien selama di IKO	IKO	-	9.32%											0
29	Kejadian kegagalan pembiusan SAB, sehingga prosedur dialihkan menjadi pembiusan GA	IKO	0	0											0
30	Keterlambatan hasil patologi anatomi sesuai dengan regulasi	Laboratorium	0	24											0
31	Surveilans harian hemovigilance "Kejadian Reaksi Transfusi"	Laboratorium	100%	100%											<3%

32	Ketersediaan kantong darah sesuai golongan darah	Laboratorium	98.5%	100%											100%
33	Kejadian ketidakcocokan hasil bacaan radiologi dengan klinis pasien	Radiologi	0	16											0
34	Kejadian keterlambatan hasil radiologi sesuai dengan regulasi	Radiologi	0	40											0
35	Kepatuhan penggunaan alat pelindung diri (APD) oleh petugas pengolahan	Instalasi Gizi	-	91.09%											100%
36	Kepatuhan identifikasi pasien oleh penyaji	Instalasi Gizi	-	100%											100%
37	Angka Kelengkapan Pengkajian Gizi	Instalasi Gizi	100%	100%											100%
38	Kejadian kesalahan pemberian diet	Instalasi Gizi	2	1											0
39	Kejadian adanya benda asing dalam makanan	Instalasi Gizi	0	0											0
40	Kejadian makanan basi	Instalasi Gizi	1	1											0
41	Angka keterlambatan penyediaan obat jadi rawat jalan >30 menit.	Farmasi	-	43.56%											0%
42	Kejadian ketidakpatuhan retur obat rawat inap	Farmasi	0	0											0
43	Kejadian Kesalahan Penyiapan Obat	Farmasi	2	4											0

44	Kejadian Kesalahan Pemberian Obat	Farmasi	1	2											0
45	Kejadian Kesalahan Penulisan Etiket Obat	Farmasi	1	0											0
46	Kejadian Kesalahan Input E-Resep	Farmasi	1	4											0
47	Keterlambatan sediaan farmasi datang	Pengada an Farmasi	-	20.6%											0%
48	Kesalahan pembelian sediaan farmasi	Pengada an Farmasi	-	0%											0%
49	Angka selisih stok opname	Pengada an Farmasi	-	0.88%											0%
50	Respon time memasukkan master barang baru 1X24 Jam	Pengada an Farmasi	-	93.75%											≥95%
51	IDO (Infeksi Daerah Operasi)	PPI	0%	0%											≤ 2 %
52	IADP (Infeksi Aliran Darah Primer)	PPI	0%	0%											≤3,5‰
53	VAP (Ventilation Associated Pneumonia)	PPI	0 ‰	0 ‰											≤ 5,8 ‰
54	ISK (Infeksi Saluran Kencing)	PPI	0 ‰	0 ‰											≤ 4,7 ‰
55	Infeksi Aliran Darah Perifer /ILI (Phlebitis)	PPI	0.35%	0.3%											≤ 5 %

56	Angka Decubitus	PPI	0%	0%											0%
57	Kejadian petugas tertusuk jarum bekas pasien (pajanan)	PPI	0	0											0
58	Kejadian keterlambatan pengurusan SIP/SIK	SDM	0%	4.72%											0
59	Angka turn over staf	SDM	1.4%	0%											0%
60	Kesalahan pendaftaran pasien	Pendaftar	-	25											0
61	Kejadian pasien BPJS TK tidak memasukkan dalam system E-PLKK	Pendaftar	-	4											0
62	Kejadian ketidaksesuaian tanggal pengunjungan pasien RI dengan SPRI	Pendaftar	-	0											0
63	Ketidakpatuhan pembuatan PCRA	K3RS	-	0											0
64	Waktu pengajuan klaim	Asuransi Center	Tgl 5	Tgl 5											Tgl 5 awal bulan
65	Klaim pending RJTL	Asuransi Center	0	-											<0.1%
66	Klaim pending RITL	Asuransi Center	0	-											<1%
67	Klaim tidak layak	Asuransi Center	0	-											0%

68	Nilai Pengembalian Audit Klaim RJTL	Asuransi Center	0	-											<1 juta
69	Nilai Pengembalian Audit Klaim RITL	Asuransi Center	0	-											<5 juta
70	Nilai selisih negatif klaim RJTL	Asuransi Center	251.175.040	232.420.655											<50 juta
71	Nilai selisih negatif klaim RITL	Asuransi Center	- 1.216.032.654	-											<100 juta
72	Persentase readmisi pasien rawat inap	Asuransi Center	3.5%	1.8%											0%
73	Angka kelengkapan berkas klaim di SIMRS	Asuransi Center	66.4%	58%											100%
74	Angka keterlambatan penanganan pelaporan kerusakan oleh unit dalam 1x24 jam	IPSRS	93.15%	97.8%											100%
75	Kejadian kerusakan sarana prasarana	IPSRS	124	156											0
76	Ketidakpatuhan pengambilan barang oleh unit	Gudang Umum	4	8											0
77	Respon time menanggapi keluhan unit <10 menit	Cleaning Service	90.91%	79.1%											≥ 90%
78	Angka ketidakiengkapan pengumpulan dokumen meeting RS (saat akhir rapat)	Sekretariat	25%	0%											0%

79	Kejadian linen ruang perawatan hilang	Laundry	0	16											0
80	Kejadian tercampur benda asing	Laundry	1	0											0
81	Kejadian keterlambatan penyediaan kasa steril	CSSD	2	0											0
82	Kejadian ditemukannya instrument hilang atau kurang	CSSD	0	0											0
83	Kejadian CCTV tidak terecord	IT	0	0											0
84	Kejadian Komputer dan internet lemot	IT	60	53											0
85	Ketidakpatuhan pencatatan buku transit jenazah	Kamar Jenazah	0%	0%											0%
86	Kejadian permintaan driver yang bersamaan	Driver	0	4											0%
87	Kejadian Oncall driver	Driver	3	5											0
88	Penggunaan ambulance Luar RS	Driver	12	11											0
89	Kelolosan tamu tidak menggunakan kartu visitor	Security	1	0											0
90	Kejadian ketidaktertiban pengunjung rawat inap	Security	15	14											0
91	Kesalahan pelunasan yang dilakukan	Kasir	2	5											0

92	Keterlambatan pelunasan pembayaran	Kasir	1	1											0
93	Kejadian pemulangan pasien rawat inap lebih dari 15 menit	Kasir	0	4											0
94	Keterlambatan perpanjangan perjanjian kerja sama	Humas	0	0											0
95	Kejadian komplain pasien karena keterlambatan pengantaran obat	Primanta ra	1	1											0
96	Kepatuhan PPA dalam pengisian form edukasi kolaborasi	PKRS	-	-											100%
97	Angka Kelengkapan Dokumentasi Metode SBAR dan Konfirmasi "Read Back" pada Instruksi Verbal	PKRS	-	-											100%
98	Angka Kepatuhan Petugas dalam Survei kelengkapan Form Edukasi Kolaborasi Oleh PPA	PKRS	-	-											100%
99	Angka kepatuhan petugas dalam memberikan edukasi Kelompok	PKRS	-	-											100%
100	Angka kepuasan pasien peserta BPJS	PIPP	99.89%	100%											100%
101	Angka terhubungnya display TT dengan mobile JKN	PIPP	100%	100%											≥ 90%
102	Angka terhubungnya operasi dengan mobile JKN	PIPP	100%	100%											≥ 90%
103	Angka Pasien Terkonfirmasi Bakteriologis	PROGN AS TB	100%	100%											100%

104	Angka capaian pelayanan KB per metode kontrasepsi, baik Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) dan Non MKJP	PROGN AS KB	25.6%	7.44%											100%
105	Angka capaian pelayanan KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran	PROGN AS KB	23.9%	9.9%											70%
106	Kejadian tidak dilakukannya KB Pasca Persalinan pada ibu baru bersalin dan KB Pasca Keguguran pada Ibu pasca keguguran	PROGN AS KB	92	94											0
107	Angka Pelaksanaan kunjungan rumah dan PKM pasien Stunting & Wasting	PROGN AS STUNTI NG	-	-											100%
108	Angka Kepatuhan Petugas dalam Memberikan edukasi kelompok sebagai upaya Pencegahan Stunting & Wasting (4x/bln)	PROGN AS STUNTI NG	-	-											100%
109	Angka pasien terkonfirmasi bakteriologis	PROGN AS TB	100%	100%											
110	Angka kepatuhan petugas dalam melakukan skrining dan testing pasien dengan resiko HIV/AIDS	PROGN AS HIV													100%

IKP FEBRUARI 2026

No.	TGL KEJADIAN	STAF YG TERLIBAT		Jenis IKP	KRONOLOGI	TINDAK LANJUT
		NAMA	UNIT			
1.	2 Februari		Farmasi	KTC	Kesalahan pemberian obat karena kesalahan order permintaan obat dan semua petugas farmasi tidak melakukan double check	- Melakukan pengecekan ulang pada saat packing resep dan sebelum diserahkan pada pasien - Peningkatan kedisiplinan penulisan paraf pada label ISEP sehingga dapat diketahui petugas yang melakukan input, penyiapan, etiket maupun KIE
2.	2 Februari	Elis, Defi, Lilis	Farmasi	KTC	Kesalahan pemberian obat karena obat pasien tertinggal (tidak diberikan pada pasien)	- Melakukan pengecekan ulang pada saat packing resep dan sebelum diserahkan ke pasien - Peningkatan kedisiplinan penulisan paraf pada label ISEP sehingga dapat diketahui petugas yang

						melakukan input, penyiapan, etiket maupun KIE
3.	5 Februari	Dokter Dicky		KPC	Kesalahan input e-resep	Koordinasi dengan komite medik dan kepala bidang pelayanan medis
4.	5 Februari	Dokter Zora		KNC	Kesalahan input e-resep	Koordinasi dengan komite medik dan kepala bidang pelayanan medis
5.	5 Februari	Dokter icky		KPC	Kesalahan input e-resep	Koordinasi dengan komite medik dan kepala bidang pelayanan medis
6.	10 Februari	Dokter Hum		KNC	Kesalahan input e-resep	Koordinasi dengan komite medik dan kepala bidang pelayanan medis
7.	5 Februari			KTC	Kejadian makanan basi	- Melakukan QC secara keseluruhan terhadap makanana pasien - Tidak membuat bahan makanan setengah jadi jauh jauh hari

						- Selalu memberi label tanggal pembuatan makanan setengah jadi
8.	28 Februari	Alfira		KTC	Pasien mendapat makan yang tidak sesuai advice karena permintaan belum di update oleh DPJP	- Membaca ulang secara keseluruhan dari daftar diet yang di update - Fokus bekerja / tidak bermain hp di luar urusan pekerjaan
9.	5 Februari 2026		Laborat	KPC	Ditemukan tumpahan air yang dapat menimbulkan risiko jatuh pada petugas maupun pasien	Segera memasang tanda risiko jatuh dan melaporkan kepada tim cleaning service
10.	6 Februari 2026		IGD	KPC	Ditemukan tumpahan air yang dapat menimbulkan risiko jatuh pada petugas maupun pasien	Segera memasang tanda risiko jatuh dan melaporkan kepada tim cleaning service
11.	6 Februari 2026		IRNA 7A	KPC	Ditemukan tumpahan air kencing yang dapat menimbulkan risiko jatuh pada pasien	Segera memasang tanda risiko jatuh dan melaporkan kepada tim cleaning service
12.	10 Februari 2026		Laborat	KPC	Ditemukan tumpahan air yang dapat menimbulkan risiko jatuh pada petugas maupun pasien	Segera memasang tanda risiko jatuh dan melaporkan kepada tim cleaning service

13.	27 Februari 2026			KTD	Kejadian pasien jatuh di ruangan karena pasien tidak di tunggu oleh keluarga dan keluarga tidak menitipkan kepada perawat, sehingga perawat tidak memindahkan pasien ke kamar yang dekat dengan NS	Melakukan KIE pada keluarga untuk menjaga pasien dan melakukan edukasi terkait upaya pencegahan risiko jatuh
-----	---------------------	--	--	-----	--	--

BAB IV
PENUTUP

Demikian Laporan Komite Mutu rumah sakit di Rumah Sakit Prima Husada Malang Bulan Februari Tahun 2026. Upaya yang dilakukan adalah upaya maksimal yang bisa dikerjakan saat ini, tentunya upaya yang berkesinambungan dan tidak mengenal lelah terus dilakukan sehingga tercapai hasil tertinggi bagi semua komponen pemberi dan pengguna layanan rumah sakit.

Malang, 10 Maret 2026

Ketua Komite PMKP



dr. Diah Puspita Rifasanti, Sp.M

PLT Direktur RS Prima Husada Malang



dr. Resti Lestantini, M.Kes